

Akutt appendisitt

Bakgrunn

Blindtarmsbetennelse. Akutt betennelse i blindtarmsvedhenget. Vanligste årsak til akutt abdomen. Livstidsinsidens på ca. 8 %. Kan opptre i alle aldre, men forekommer hyppigst i aldersgruppen 10–30 år og hos menn.

Symptomer og funn

Abdominal smerter <3 døgn. Ofte debut midt i abdomen og forflytning mot nedre høyre kvadrant i løpet av noen timer. Varierende smerteintensitet. Smerteforverrelse ved bevegelse og bruk av bukpressen (hoste). Spisevegring, kvalme og vanligvis også oppkast. Rødme i ansiktet. Lett forhøyet temperatur. Palpasjonsømheter i høyre nedre del av abdomen med punctum maximum i McBurneys punkt (ligger på overgangen mellom laterale og midtre tredjedel på en linje mellom spina iliaca anterior superior og umbilicus). Slippømheter. Smerter (ventralt) ved rektaleksplorasjon. Eventuelt reduserte tarmlyder. Ofte positivt [iliopsoastegn](#). Lavgradige symptomer eller atypisk smertelokalisasjon forekommer ofte hos små barn og eldre, gravide, adipøse og personer som blir behandlet med steroider eller antibiotika, og ved retrocoecal appendisitt. Peritonittsymptomer er ofte fraværende hos immunsupprimerte.

Klinisk skåringssystem ved mistanke om appendisitt (1 poeng pr. punkt), modifisert MANTRELS skår:

- Smertevandring til nedre høyre kvadrant
- Smerteforverrelse ved hoste og bevegelse
- Kvalme, oppkast, diaré (alle 3 til stede i anamnesen)
- Rubor i ansiktet (flushing)
- Trykkømheter i nedre høyre kvadrant
- Voluntær stramming (avverge) og slippømheter i nedre høyre kvadrant
- Ømheter oppad til høyre ved rektaleksplorasjon

Skår	Tolkning
0–1 poeng	Neppe appendisitt, kan observeres hjemme. Avtal ny kontakt.
2 poeng	Sannsynligvis ikke appendisitt, men bør observeres .
3 poeng	Betydelig mistanke om appendisitt. Innlegges kirurgisk avdeling.
4–7 poeng	Sannsynlig appendisitt

Supplerende undersøkelser

- **Blodprøver?** Eventuelt CRP, leukocytter. Begrenset verdi. Begge prøvene kan være forhøyet, men er ofte normal ved sykehistorie <24 timer.
- **Urin.** Urinstiks med tanke på urinveisinfeksjon og u-hCG hos fertile kvinner for å utelukke svangerskap (differensialdiagnoser).

Differensialdiagnoser

- **Mesenteriell lymfadenitt.** Diagnosen stilles ved funn av forstørrede lymfeknuter i mesenteriet og normal appendiks under operasjon ved mistanke om appendisitt. Ukjent årsak, muligens viral. Forekommer ofte samtidig med øvre luftveisinfeksjon og sår hals. Hyppigere hos barn enn hos voksne. Feberen er ofte høyere enn ved akutt appendisitt, og buksmertene kan sitte mer diffust i buken.
- **Gynekologiske tilstander** som for eksempel [ekstrauterin graviditet](#), [akutt bekkeninfeksjon](#), rumpert ovarialcyste eller ovarialtorsjon, endometriose, Mittelschmerz.
- **Sykdommer i urinveiene**, som [cystitt](#), [pyelonefritt](#), nyrestein.
- **Andre tilstander i mage-tarmsystemet**, som Inkarserert [hernie](#), Crohns sykdom, [akutt kolesystitt](#), perforert [magesår](#), Meckels divertikulitt, gastroenteritt.
- **Testistorsjon.** Scrotum må undersøkes hos små gutter.
- **Øre-nese-hals-infeksjoner.** Kan gi magesmerter hos barn.

Tiltak

- **Innleggelse?** Ved mistanke om appendisitt (klinisk skår >2) innlegges pasienten akutt i kirurgisk avdeling. Pasienten holdes fastende. For håndtering ved generell peritonitt, se [peritonitt](#).
- **Observasjon?** Ved klinisk skår <2 kan pasienten observeres hjemme. Avtal rekontakt ved forverring. Ved klinisk skår 2 bør pasienten observeres ved legevakten, i kommunal øyeblikkelig hjelp døgnenhet eller i kirurgisk avdeling.

Komplikasjoner

Perforasjon med peritonitt og fare for abscessdannelse subfrenisk eller i fossa Douglasi. Kronisk appendisitt. Abscessdannelse rundt ubehandlet akutt appendisitt.